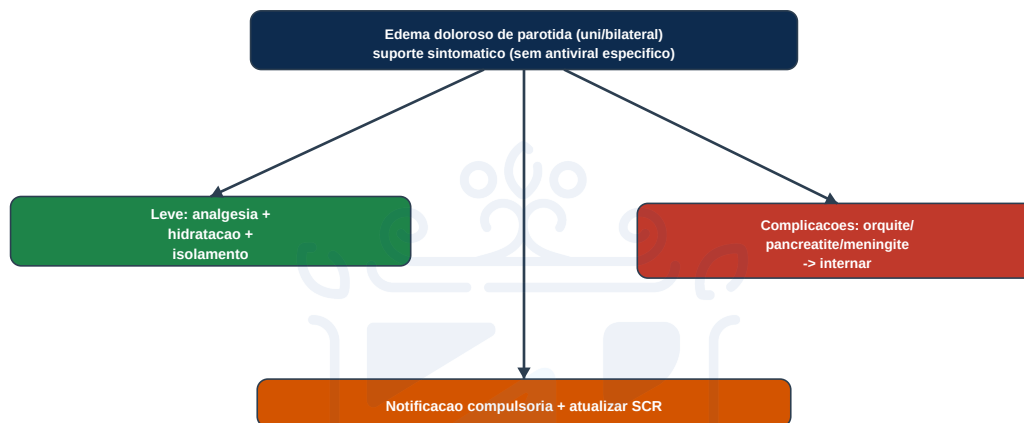


CAXUMBA — PAROTIDITE + COMPLICAÇÕES

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

CAXUMBA — PAROTIDITE -> RASTREAR COMPLICAÇÕES



DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

O QUE É

- Doença viral sistêmica aguda contagiosa (Orthorubulavirus, Paramyxoviridae); inflamação dolorosa das glândulas salivares, sobretudo PARÓTIDAS
- Transmissão: gotículas respiratórias, saliva, contato com secreções orais; incubação 12-25 dias
- Transmissibilidade: de 2 dias antes até 5 dias após o início da parotidite
- Fatores de risco: não vacinados/esquema incompleto, ambientes coletivos; adolescentes/adultos jovens têm MAIOR risco de complicações
- Pode complicar com manifestações neurológicas, genitais e pancreáticas; notificação compulsória

AValiação

EXAME DIRIGIDO

- Anamnese: início do edema parotídeo, dor à mastigação/deglutição, febre/mialgia, situação vacinal (SCR), contato com casos; dor testicular/abdominal, cefaleia intensa/vômitos/rigidez de nuca
- Local: aumento uni/bilateral da parótida, dor à palpação, DESVIO DO LÓBULO da orelha, pele sem hiperemia importante
- Sistêmico: avaliação neurológica, abdominal e TESTICULAR (homens); estado de hidratação
- Exames geralmente desnecessários; nos complicados: hemograma, amilase/lipase, PCR, US testicular, punção lombar (suspeita neurológica)
- Diferenciais: parotidite bacteriana (supurada), litíase salivar, adenite, abscesso

CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE

Forma	Características
Leve	Parotidite isolada, febre baixa/ausente, bom estado geral
Moderada	Parotidite dolorosa importante, febre persistente, dificuldade alimentar, dor abdominal leve
Grave/complicada	ORQUITE/ooforite, pancreatite, meningite/encefalite, desidratação moderada-grave, imunossuprimidos

TRATAMENTO SINTOMÁTICO

Rx SEM ANTIVIRAL ESPECÍFICO

Medidas gerais: repouso, hidratação (VO ou EV se vômitos/desidratação), ISOLAMENTO por gotículas, dieta leve/fria/pastosa evitando alimentos ácidos (aumentam a dor salivar)
Analgesia/antitérmico: Dipirona 500-1000 mg 6-8/8h (crianças 10-20 mg/kg) ou Paracetamol; EVITAR AAS em crianças/adolescentes (síndrome de Reye)
AINE se dor moderada/intensa: Ibuprofeno 400-600 mg 8/8h por curto período
ORQUITE: repouso absoluto, elevação escrotal, compressas frias, analgesia plena; corticoide NÃO de rotina (considerar prednisona 0,5-1 mg/kg/dia em dor intensa selecionada)
PANCREATITE: internação, jejum, hidratação venosa, analgesia EV; NEUROLÓGICAS: internação, avaliação + PL se indicado, UTI se instabilidade
Antibiótico NÃO indicado (exceto suspeita de parotidite bacteriana/supurada)

INTERNAÇÃO, ALTA E ORIENTAÇÕES

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: orquite dolorosa intensa, complicações neurológicas, pancreatite, desidratação moderada/grave, dor não controlada, imunossuprimidos
- ☐ ALTA: estabilidade clínica, dor/febre controladas, hidratação oral adequada, sem sinais de complicação, orientações compreendidas
- ☐ Casa: Dipirona/Paracetamol + Ibuprofeno se dor moderada; repouso 7-10 dias; compressas frias na parótida; isolamento domiciliar por 5 dias após o início do edema
- ☐ Orientar: evitar esforço físico; evitar contato com gestantes e imunossuprimidos; retorno se dor testicular, cefaleia intensa, vômitos persistentes ou rebaixamento
- ☐ Notificação compulsória; avaliar/atualizar esquema vacinal (SCR)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com parotidite ____ (uni/bilateral) há ____ dias; vacinação SCR ____; contato ____.
- Complicação: orquite ____ / pancreatite (amilase/lipase ____) / neurológica (cefaleia/rigidez/vômitos ____).
- Conduta: analgesia ____, hidratação ____, isolamento; orquite (elevação/compressa) / pancreatite (jejum + EV).
- Solicito internação por ____ (orquite intensa / pancreatite / complicação neurológica); notificar Vigilância.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a complicação mais temida da caxumba em adolescentes e adultos do sexo masculino?

- A) Artrite
- B) Orquite (com risco de atrofia testicular)
- C) Hepatite
- D) Nefrite
- E) Pneumonia

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o tratamento da caxumba?

- A) Antiviral específico
- B) Sintomático e de suporte (analgesia, hidratação, isolamento), sem antiviral específico
- C) Antibiótico de rotina
- D) Corticoide para todos
- E) Imunoglobulina

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual analgésico/antitérmico deve ser EVITADO em crianças e adolescentes com caxumba?

- A) Dipirona
- B) AAS (ácido acetilsalicílico), pelo risco de síndrome de Reye
- C) Paracetamol
- D) Ibuprofeno
- E) Nenhum

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual exame ajuda a confirmar pancreatite associada à caxumba?

- A) Amilase e lipase
- B) Hemoglobina glicada
- C) TSH
- D) Sorologia para dengue
- E) PSA

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre a prevenção da caxumba, é correto:

- A) Não há vacina
- B) A vacinação (tríplice viral - SCR) é a principal forma de prevenção, e a doença é de notificação compulsória
- C) Antibiótico profilático para contatos
- D) Isolamento não é necessário
- E) Só ocorre uma vez na vida sem necessidade de vacina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A orquite é a complicação mais temida em adolescentes/adultos do sexo masculino, com risco de atrofia testicular; o manejo inclui repouso, elevação escrotal, compressas frias e analgesia.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Não há antiviral específico: o tratamento é sintomático e de suporte (analgesia, hidratação, isolamento por gotículas).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Evita-se o AAS em crianças e adolescentes pelo risco de síndrome de Reye; usam-se dipirona/paracetamol ($\pm$ ibuprofeno se dor moderada).

QUESTÃO 4 → Resposta: A

A elevação de amilase e lipase apoia o diagnóstico de pancreatite associada à caxumba, que indica internação, jejum e suporte.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A vacinação com a tríplice viral (SCR) é a principal forma de prevenção; a caxumba é de notificação compulsória, com avaliação do esquema vacinal.

SM24
Suporte ao Plantão Médico